

Fecha Última Actualización: 09-06-2022 17:50:22

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Juan Arce Espinoza **Rut** : 4.497.459-2 **N° Archivo** : 2210087
Edad : 78a 3m 22d **Fecha Nacto**: 18/02/1944 **Sexo** : Masculino
Dirección : Pedro Hunneus 0700 V. Sto. Tomas **Comuna** : La Pintana **Teléfono** :

N° Epicrisis
308168

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 21/05/2022 18:57 **Días Estadía**: 19
Unidad de Egreso : Utim **Fecha Egreso** : 09/06/2022 14:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Cefalea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

I. Identificación:

Nombre: Juan Arce Espinoza

Edad: 78 años

RUT: 4497459-2

Contacto: Mirta Araya (hija), 978274229

FI CASR: 21/05/2022

FI UPC: 22/05/2022

II. Antecedentes:

Médicos: DM2 NIR, HTA, ACV (hija refiere 2 episodios de ACVs previos, con secuela con leve paresia en pie -no recuerda cual -).

Quirúrgicos: No

Fármacos: Enalapril, atorvastatina, AAS

Alergias: No

Hábitos: TBQ no, OH no, Drogas no

Inmunizaciones: COVID (4 dosis), influenza (+)

III. Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos, derivado desde HPH a Reanimador UEA CASR en contexto de cuadro de cefalea ictal de intensidad EVA 10/10 (que inicia el 21/05/2022), con evidencia de HSA fina con patrón aneurismático, escaso hemoventrículo y aneurisma de ACP derecha (Fisher IV y WFNS 1) en angioTC de cerebro.

Evaluado por neurocirugía, se determina estudio invasivo en pabellón con angiografía que evidencia:

- Gran ateromatosis difusa con estenosis en origen de arteria vertebral
- Zonas estenóticas en V4 Unión Vértebro-Basilar y A. Basilar
- Estenosis crítica de ACP izquierda
- Estenosis 70% de origen de ACI derecha con placa irregular

Fecha Epicrisis : 09/06/2022 17:50

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 09-06-2022 17:50:22

Página 2 de 4

- Ateromatosis difusa de sifón carotídeo
- Estenosis de origen de ACP derecha de origen fetal con aneurisma fusiforme en su segmento P2 de 2.5x2 mm. de diámetro

Considerando características de aneurisma, se determina fuera de alcance terapéutico endovascular sin posibilidad de exclusión, trasladándose a UPC para continuar manejo, donde ingresa en GCS 15, hemodinámicamente estable, bien perfundido, vigil, atento, sin alteraciones al examen físico neurológico compatibles con déficit focal/global, con reflejo plantar superficial flexor bilateral.

Durante estadía en UPC destaca tendencia a la hipertensión que se maneja con BIC de labetalol para control estricto con meta de PAS 160. Destacan parámetros inflamatorios al alza, con episodio febril (25/05) sin deterioro hemodinámico ni deterioro clínico, sin foco clínico evidente ni patógeno aislado. Se solicita nuevo cultivo de expectoración y se mantiene al traslado Ampicilina/Sulbactam (FI 26/05). En cuanto a sintomatología refiere sin cefalea sin embargo ha evolucionado con lumbalgia y algia en relación a pelvis intermitente. Además creatinina y BUN al alza pese a aporte de volumen.

Laboratorio 21/05/2022 (ingreso):

Hcto 38.1 Hb 13.6 Pla 181000 GB 9980 PCR 0.5
Crea 1.01 BUN 15.2 ELP 144/3.34/111
SGOT 21 SGPT 17 FA 78 GGT 17
Glucosa 106 Mg 1.6
INR 1.29 TTPA 30.3

Laboratorio 27/05/2022:

Hcto 35.7 Hb 12.5 Pla 161000 GB 13150 (PMN 75.7%) PCR 277.3
Crea 1.7 BUN 43.8 ELP 138/3.37/107
P 4.7 Gluc 89
GSV pH 7.429 pCO2 27.9 HCO3 18.1
INR 1.32 TTPA 39.9

Microbiología:

21/05 PCR COVID: Negativo
25/05 SO no inflamatorio/UC PMB
25/05 Cultivo corriente: Muestra no apta
25/05 HC I y II: Pendientes

Examen físico:

A la evaluación vigil, orientado adecuadamente en tiempo y espacio, atento
Obedece órdenes, M5 en 4 extremidades
Perfusión adecuada, CRT 3 segundos, tibio a distal
Hidratación adecuada
Yugulares no ingurgitadas
Auscultación cardiopulmonar: RR2TSS, MP (+) con escasas sibilancias en ambas bases
Abdomen: RHA (+) aumentados, BDI, s/SIP, sin masas, sin vísceromegalias
Extremidades: Sin edema, sin signos sugerentes de TVP, pulsos distales presentes simétricos

Diagnósticos de ingreso a UTIM:

1. Hemorragia subaracnoidea aneurismática
1. Fisher IV - WFNS 1
2. Aneurisma de ACP derecha segmento P2, fuera de alcance terapéutico endovascular
2. AKI KDIGO II oligúrica (1000 cc. cada 24 horas) (0.6 cc/hora)
3. Síndrome febril sin foco, en estudio

Evolución durante estadía en UTIM:

Plan(es):

Hemodinamia: Cursó con HTA de difícil manejo, con meta de PAS 160 con req. de 5 VDO. Requirió BIC de labetalol por un período prolongado, logrando suspensión el 05/06. Destaca caída de Hb progresiva durante hospitalización, al ingreso Hb 14.4 y en hemograma formal de control Hb 11, perfil de Fe sin mayores alteraciones con ferritina elevada, pendiente niveles

Fecha Epicrisis : 09/06/2022 17:50

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 09-06-2022 17:50:22

Página 3 de 4

de VitB12, impresiona principal componente AEC. En seguimiento.

Respiratorio: Asintomático desde el punto de vista respiratorio, en TC previo (HPH) se visualizan nódulos y engrosamiento pleural, por lo que se solicita TC de tórax contrastado para evaluación dirigida, que informa dichos nódulos como calcificaciones pleurales parietales. Se solicita ev. por cx. de tórax, impresionan modificaciones inflamatorias/cicatriciales de pleura, sin indicación de biopsia ni resección quirúrgica.

Neuroquirúrgico: Ingresa en contexto de HSA por aneurisma disecante de Arteria Comunicante Posterior Derecha, en contexto de ateromatosis extensa de vasos cerebrales, sin posibilidad de exclusión y fuera de alcance de resolución endovascular ni neuroquirúrgica en etapa aguda. Se mantiene en seguimiento por equipo de neurocirugía, se solicita TC y AngioTC de control, será reevaluado en comité para determinar conducta neuroquirúrgica/endovascular. Paciente manifiesta oposición a resolución quirúrgica. Se mantiene manejo médico, medidas de neuroprotección y profilaxis de vasoespasma con nimodipino (día 18, a cumplir 21 días).

Infectológico: Presentó alza de PPII y peak febril, sin foco clínico evidente, sin MO, TC TAP sin foco infeccioso. Se inició empíricamente Ampicilina/Sulbactam, completando curso de 7 días. Destaca nueva elevación de PPII sin fiebre ni foco infeccioso, se mantiene en observación, actualmente en descenso. En vigilancia.

Nefrológico: Durante estadía evoluciona con deterioro de función renal, clearance calculado al ingreso de 53 cc/min (sin creatinina previa). Se aporta volumen con buena respuesta, con descenso de creatinina hasta 0.9 y CKD EPI en 64 cc/min, con imagen con HUN bilateral en contexto de UOP y APE 39.7. Al instalar SF evoluciona con hematuria ex vacuo. Evaluado por urología, impresiona falla renal asociada a UOB, reinterconsultar SOS o una vez estable, mantener CUP. Se mantiene control seriado de FR.

Metabólico: Paciente con antecedente de DM2 NIR, control seriado de HGT con resultado en rango. Sin req. de insulina correccional.

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS:

Nimodipino 60 mg. cada 4 horas (FI 22/05) VO, a completar 21 días (HASTA 12/06)

Enalapril 10 mg. AM - 5 mg. PM VO

Hidralazina 100 mg. cada 8 horas VO

Isosorbide 10 mg. cada 8 horas VO

Doxazosina 4 mg. cada 12 horas VO

Levetiracetam 1 gr. cada 12 horas VO

Atorvastatina 20 mg. cada 24 horas VO (PM)

Paracetamol 1 gr. EV SOS (máximo cada 8 horas)

PEG 15 gr. en 200 cc. de agua cada 12 horas (titular para deposiciones diarias)

Tamsulosina 0.4 mg al día. VO

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada -

Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada - Aki Kdigo II Oligúrica, Postrenal

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales

Hemodinámicamente estable

Sin apremio respiratorio

Sin req. de oxígeno

Asintomático

INSTRUCCIONES:

- Paciente de alta con hospitalización domiciliaria, a cumplir indicaciones realizadas por equipo tratante, a ser modificadas eventualmente por equipo de atención domiciliaria en contexto de evolución clínica.

- Solicitar con documento de epicrisis y con interconsulta, horas médicas en CDT (Neurocirugía y Urología) para continuar seguimiento.

- Paciente con retención de orina en relación a hiperplasia prostática, con falla renal durante hospitalización por retención de

Fecha Epicrisis : 09/06/2022 17:50

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 09-06-2022 17:50:22

Página 4 de 4

orina, se debe mantener al alta con Sonda Foley (catéter urinario) hasta control con urología.

CONTROLES AL ALTA:

Control en 14 días con Neurocirugía (Dr. Juan Carlos Zamora, Endovascular), solicitar hora con Epicrisis

Control en CDT con urología, solicitar hora en CDT con Interconsulta (se adjunta documento al traslado)

Plan Post Alta

Régimen: Sin restricción de consistencias, de preferencia blando, hiposódico, diabético

Alimentación pausada, sentado a 90°

Oxígeno: SOS para SpO2 > 92%

HGT AM

KNT: R y M

Mantener CUP (uropatía obstructiva por HPB) (SF #20, instalada hace 7 días)

Nimodipino 60 mg. cada 4 horas (FI 22/05) VO, a completar 21 días

Enalapril 10 mg. AM - 5 mg. PM VO

Hidralazina 100 mg. cada 8 horas VO

Isosorbide 10 mg. cada 8 horas VO

Doxazosina 4 mg. cada 12 horas VO

Levetiracetam 1 gr. cada 12 horas VO

Atorvastatina 20 mg. cada 24 horas VO (PM)

Paracetamol 1 gr. EV SOS (máximo cada 8 horas)

PEG 15 gr. en 200 cc. de agua cada 12 horas (titular para deposiciones diarias)

Tamsulosina 0.4 mg al día. VO

Indicaciones

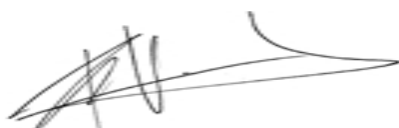
Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Con 200 G De Hidratos De Carbono

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Paula María Becado Varela Carmo
Becado/Residente


Sebastián Oksenbeg Sharim
Médico Tratante (Staff)